CAPÍTULO III – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

As recolhas dos dados foram realizadas no período da manhã, durante três (3) semanas do mês de Outubro de 2020, com a finalidade de recolher as opiniões e/ou contribuições dos utentes relativamente a qualidade de atendimento prestado nesta área de saúde, mediante o inquérito por questionário.

De salientar que foram previstos recolher dados de 97 utentes, mas felizmente conseguimos de 100 utentes.

3.1 Análise Descritiva dos Resultados

Para o tratamento Estatístico dos dados resultantes do inquérito, utilizou-se o software de aplicação Microsoft Office *Excel 2016* para a análise, extracção dos gráficos e tabelas bem como algumas medidas e estimativas.

- **Género ou Sexo**

A distribuição dos utentes que constituíram a amostra apresenta diferenças significativas em relação ao género. Do gráfico abaixo, constatamos que cerca de 64% dos utentes inqueridos é do género feminino e apenas 36% é do género masculino.

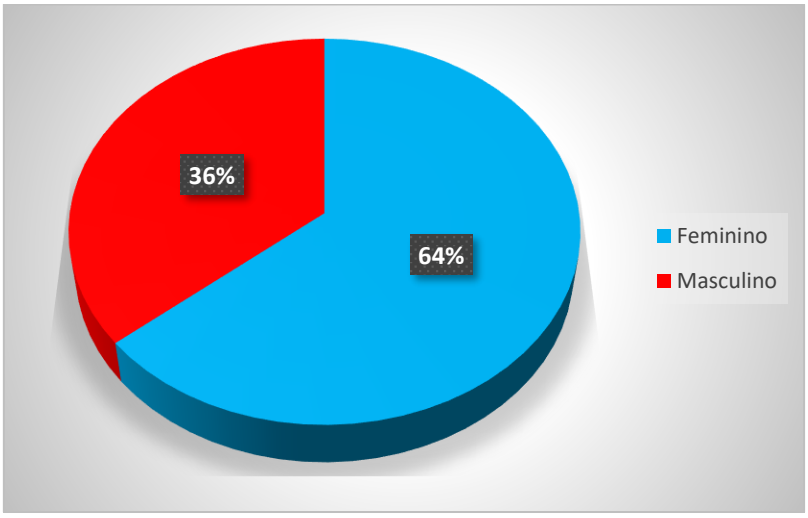


Figura 2: Distribuição da amostra em função do Género

- **Faixa etária dos Utentes**

No que diz respeito ao grupo etário, percebe-se que os utentes inqueridos são maioritariamente jovens, de idade compreendidas entre 21 e 35 anos de idade,

representando 67% dos utentes. Segue-se os utentes na fase adulta com 19% e adolescentes com 14% do total de utentes inqueridos.

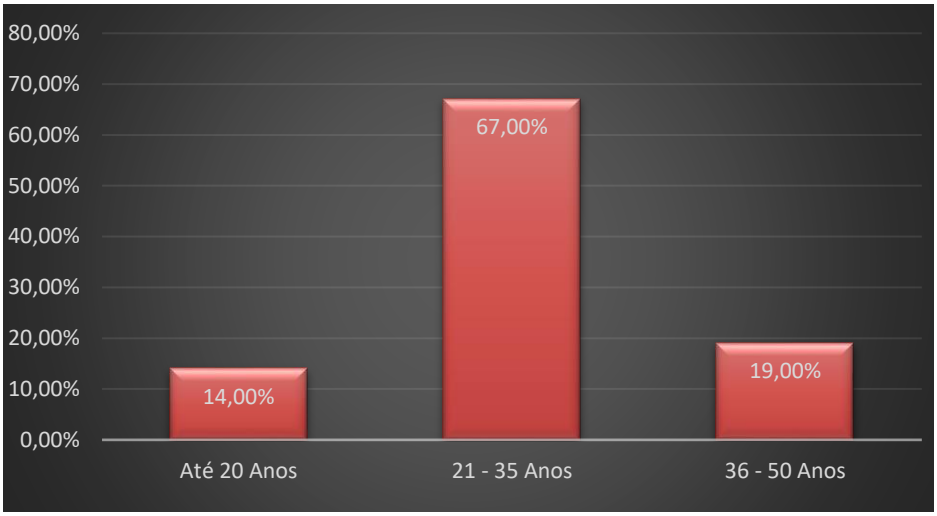


Figura 3: Distribuição da amostra em função da idade.

- **Motivo vs Evolução da Saúde**

Tabela 1: Relação entre os motivos que levaram a frequentar ASAG e a evolução do estado de saúde.

	Evolução do estado de saúde				
Motivos	**Manteve-se**	**Melhorou**	**Piorou**	**NS/NR**	**Total Geral**
Outros: Orientação do terceiro	8,00%	13,00%	6,00%	4,00%	31,00%
Preços	0,00%	2,00%	0,00%	0,00%	2,00%
Qualidade de Serviços	26,00%	14,00%	1,00%	2,00%	43,00%
Questões Geoestratégicas	7,00%	15,00%	2,00%	0,00%	24,00%
Total Geral	**41,00%**	**44,00%**	**9,00%**	**6,00%**	**100,00%**

Relativamente aos motivos que levaram os utentes a frequentar ASAG e a consequente evolução do estado de saúde, percebe-se que 31% dos utentes frequentou a referida área de saúde sob orientação do terceiro onde 13% destes notou melhoria do estado da saúde e 6% constatou aumento de complicações na sua saúde.

Percebe-se ainda que dos 43% dos utentes que acredita que a qualidade dos serviços é a razão de frequentar esta área de saúde, cerca de 26% não sentiu a evolução de seu estado de saúde.

- **Estado Civil**

Pela observação do gráfico a seguir, verifica-se que os utentes de estado civil solteiros, representam maioritariamente a amostra com 72%, seguida de 13% dos que são casados e os que estão em união de facto e divorciados, representam 8% e 7% da amostra respectivamente.

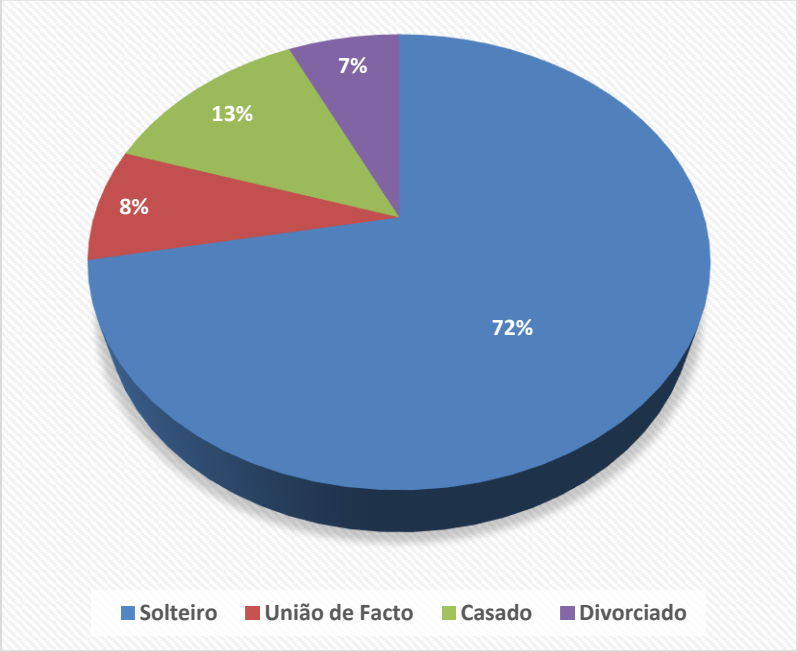


Figura 4: Distribuição do estado civil

- **Satisfação em função das Razões que levam a frequentar ASAG**

Tendo em conta que o ser humano é inclinado para aquilo que lhe dá prazer e de boa qualidade, a partir dos dados verifica-se que dos 68% de utentes satisfeito com o tempo que demorou a consulta, cerca de 30% desses utentes frequenta o ASAG devido a qualidade dos serviços, seguido de 19% que frequenta a referida área de saúde sob orientação do terceiro e 17% devido a localização geográfica desta área.

Relativamente aos utentes insatisfeitos, que representam 18% da amostra, cerca de 12% mesmo insatisfeito em relação ao tempo de consulta, frequenta a ASAG devido a qualidade dos serviços praticado na supracitada área.

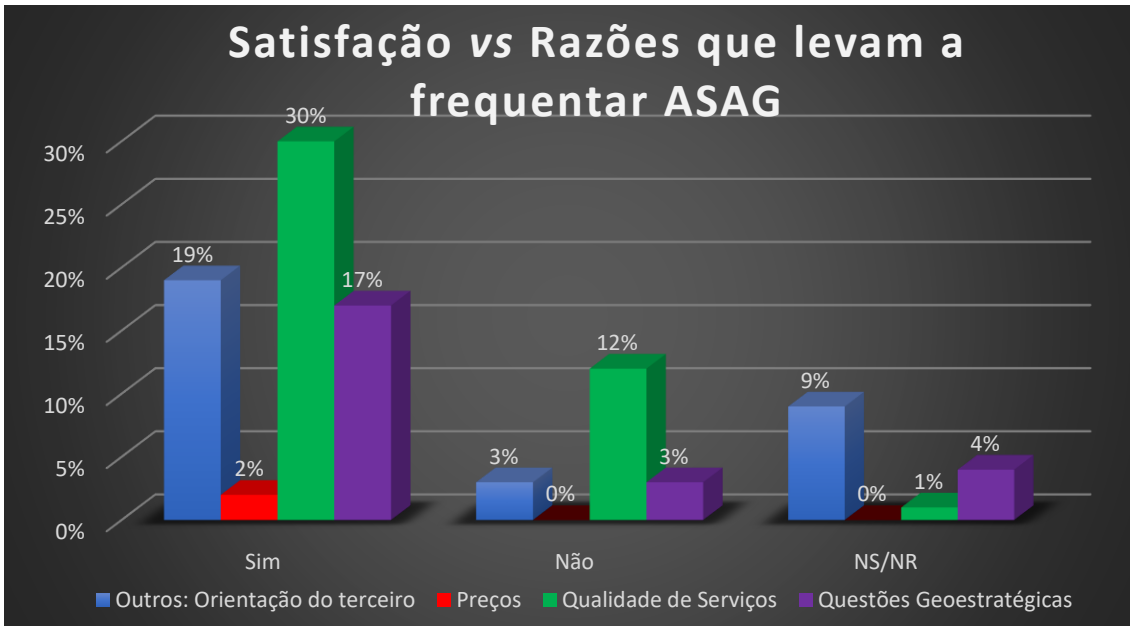


Figura 5: Tempo de Atendimento em relação ao Género

- **Satisfação em função do Género**

No que respeita a satisfação dos utentes, verifica-se que 57% dos inquiridos de sexo feminino, embora sendo a maioria inquerida, mostra-se satisfeito com o tempo em que demorou a consulta e a relação médico paciente/utente na consulta, enquanto que 17% (maioria) dos utentes do sexo oposto mostrou-se insatisfeito.

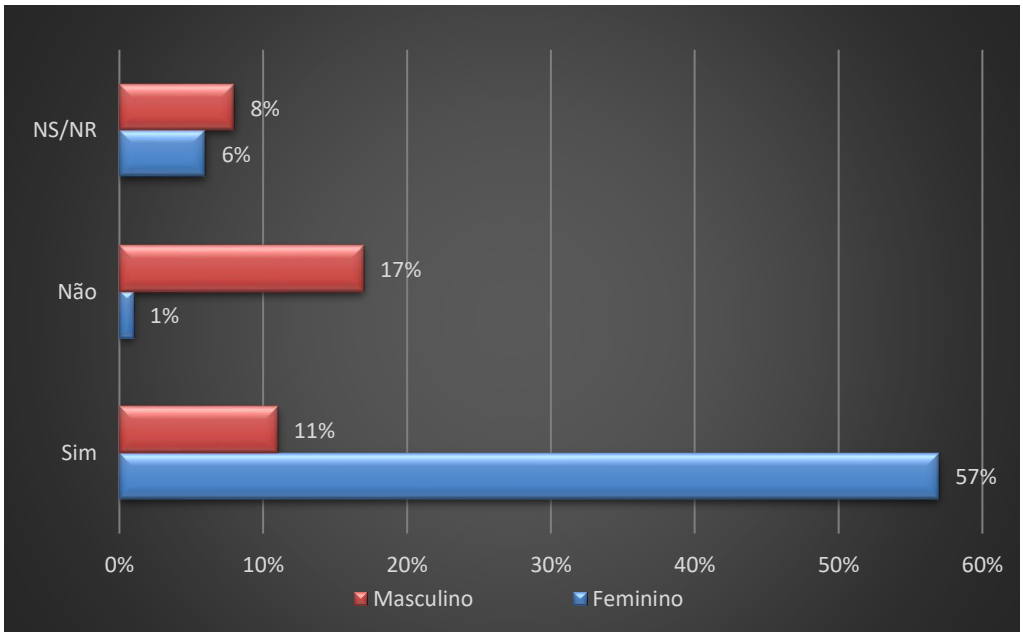


Figura 6: Satisfação em função do Género

- **Decisão sobre os cuidados de saúde vs Evolução do estado de saúde**

Tabela 2: Evolução do estado de saúde em relação a decisão sobre os cuidados de saúde.

	Evolução do estado de saúde				
Decisão Cuidado de Saúde partilhado	**Manteve-se**	**Melhorou**	**NS/NR**	**Piorou**	**Total Geral**
Muitas vezes	25,00%	33,00%	5,00%	0,00%	63,00%
Poucas vezes	16,00%	11,00%	1,00%	3,00%	31,00%
Não	0,00%	0,00%	0,00%	6,00%	6,00%
Total Geral	**41,00%**	**44,00%**	**6,00%**	**9,00%**	**100,00%**

A partir dos resultados dos inquéritos mostrados na tabela acima, podemos constatar que a interacção médico-utente está acima dos 60% onde cerca de 33% dos utentes verificou que o seu estado de saúde melhorou pese embora 25% não verificou mudanças na sua saúde.

Verificou-se ainda que dos 6% dos utentes que não tinha nenhuma interacção com o médico no que diz respeito às formas de tratamento, cuidados a ter com a saúde, ou seja, partilha de informações sobre o estado da saúde e as formas de tratamento, não percebeu avanço (melhoria) do seu estado de saúde.

- **Distribuição do Tempo de Atendimento em relação a Qualidade**

Tabela 3: Qualidade de Atendimento função do Tempo Espera para ser Atendimento

	Tempo de Espera para ser atendido				
Qualidade	**1 – 20 min**	**21 – 40 min**	**41 – 60 min**	**Mais de 60min**	**Total Geral**
Óptimo	15,00%	0,00%	4,00%	0,00%	**19,00%**
Bom	10,00%	13,00%	1,00%	2,00%	**26,00%**
Regular	14,00%	15,00%	7,00%	8,00%	**44,00%**
NS/NR	0,00%	8,00%	3,00%	0,00%	**11,00%**
Total Geral	**39,00%**	**36,00%**	**15,00%**	**10,00%**	**100,00%**

Relativamente a qualidade e o tempo de atendimento podemos constatar que 39% da população inquerida esperou no máximo 20min para ser atendido, onde 15% destes utentes considera a qualidade de atendimento óptima. Verifica-se ainda, que dos 26% dos

inquiridos que considera boa, a qualidade de atendimento, e apenas 10% da amostra espera mais de 1hora para ser atendido.

Também se verifica que 89% da população inquerida, considera a qualidade de atendimento do regular ao óptimo, o que nos permite dizer que a qualidade de atendimento é um dos factores que estão na base da busca de cuidados de saúde no referido centro.

Opinião dos Utentes nos aspectos a serem melhorados

Diante de todos os dados aqui tratados e interpretados, para mais de 50% dos utentes conhecedores das dificuldades que o país enfrenta e atravessa, manifestou as suas satisfações em relação ao atendimento medico-utente/paciente: *"Fiquei particularmente satisfeito com a qualidade do atendimentos dos médicos* (…)*"*, mas não deixam de lado as suas insatisfações em ralação ao tempo de espera para serem atendidos: *"*(…) *não gostei do tempo que demorei para ser atendido* (…)*"*, outros acrescentam ainda: *"*(…) *não gostei de trabalho de triagem porque param de chamar quem está a espera a muito tempo para chamar outros que não se sabe se tava marcado mesmo* (…)*"*.

Como forma de mitigar tais impactos na vida dos utentes, alguns apresentam algumas sugestões como: *"*(…) *caso poder alterar alguma coisa propunha a rigor nos sistemas do atendimento FIFO – primeiro a chegar é o primeiro a ser atendido* (…)", *"*(…) *caso poder alterar alguma coisa propunha que o trabalho tivesse mais controlo e a responsabilidade com os pacientes* (…)*"*.

Tabela 4: Informações estatísticas sobre a Idade dos utentes

Resumo das Estatísticas da Idade	
Média	28,35
Erro-padrão	0,704441178
Mediana	28
Moda	24
Desvio-padrão	7,044411783
Variância da amostra	49,62373737
Curtose	-0,719073263

Assimetria	0,492766752
Mínimo	17
Máximo	45
Contagem	100
Nível de confiança (95%)	1,397764127

Outras informações que podemos obter ou verificar com as idades dos utentes inqueridos são sobre as centralidades e as dispersões dos mesmos.

A média das idades dos utentes inqueridos é de 28,35 anos, sendo mais frequentes os utentes de 24 anos. A idade mínima dos utentes inqueridos é 17 anos e a idade máxima de 45 anos, originando assim, uma amplitude amostral igual a 28.

No que diz respeito a dispersão das idades em torno da média, verifica-se um desvio padrão de 7,04 e a variância amostral de 49,624 e com a distribuição das idades apresentando uma assimétrica positiva (0,493).

3.2 Análise Inferencial dos Resultados

Segundo Bussab e Morettin (2002, p.264) a Inferência Estatística tem como objectivo "(…) *produzir afirmações sobre dada característica da população, na qual estamos interessados, a partir de informações colhidas de uma parte dessa população*".

Na análise inferencial (ou estatística indutiva ou inferencial) dos dados resultantes do inquérito, utilizaremos os dados da estatística descritiva, para melhor visualizar as proporções, as distribuições das idades de forma a permitir a avaliação, ou seja, inferir sobre a população os resultados obtidos do inquérito.

Nesta análise, consideramos estar presente numa distribuição normal (com média μ, e variância σ^2), ou numa distribuição Binomial para o caso de proporção.

3.2.1 Estimação por Intervalo de Confiança

Para Fernandes (1999, p.101), a estimação por Intervalo de Confiança consiste em tentar encontrar um intervalo de valores prováveis para o parâmetro da distribuição da população, a partir dos dados da amostra. Esse procedimento segundo as ideias de Bussab

e Morettin (2002, p.310) permite julgar qual a possível magnitude do erro que estamos cometendo.

- **Intervalo de confiança para a média**

Deseja-se estimar a idade média dos utentes que frequentam o ASAG. Na amostra de 100 utentes de idades conforme mostradas na tabela abaixo, construiremos um intervalo de confiança para a média populacional com nível de significância de 5%.

22	43	45	23	23	27	35	28	24	23
29	41	36	24	33	20	28	31	39	27
24	33	20	33	28	37	40	40	20	29
37	37	22	29	19	29	24	17	28	37
23	23	22	29	22	24	40	25	19	28
19	19	25	35	43	32	43	24	22	19
18	22	40	32	24	23	24	33	28	20
20	28	24	27	31	37	22	20	23	24
17	38	31	24	22	33	32	31	40	24
33	35	28	24	31	39	29	32	23	29

Dados

$n = 100$ $\quad Z_{\frac{\alpha}{2}} = 1{,}96$ $\quad \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} = \frac{2835}{100} = 28{,}35$

$\alpha = 5\% = 0{,}05$

$$s_x = \sqrt{var(x)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{100}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{9875{,}1237}{99}} = \sqrt{49{,}6237} = 7{,}04$$

$$IC(\mu, 1-\alpha): \left(\bar{x} - Z_{\frac{\alpha}{2}} * \frac{s_x}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + Z_{\frac{\alpha}{2}} * \frac{s_x}{\sqrt{n}}\right)$$

$$IC(\mu, 0{,}95) = \left(28{,}35 - 1{,}96 * \frac{7{,}04}{\sqrt{100}}; 28{,}35 + 1{,}96 * \frac{7{,}04}{\sqrt{100}}\right)$$

$$IC(\mu, 0{,}95) = (28{,}35 - 1{,}38; 28{,}35 + 1{,}38) \Leftrightarrow IC(\mu, 0{,}95) = (26{,}97\ ;\ 29{,}73)$$

A média da idade dos utentes que frequentam a ASAG encontram-se, a um nível de confiança de 95%, entre $26{,}97$ e $29{,}73$ anos de idade.

- **Intervalo de confiança para a proporção**

Tendo em conta que os utentes vão ao centro de saúde a busca de cuidados de saúde, na perspectiva de encontrar melhorias para mesma. Assim, é de extrema importância conhecer, a um nível de confiança de 99%, os limites de confiança para a proporção dos

utentes que o estado de saúde não evoluiu (manteve-se[1]) depois da consulta na ASAG, sabendo que 41% revelaram que não houve mudanças.

$$n = 50 \qquad \hat{p} = \frac{41}{100} = 0{,}41 \qquad \alpha = 1\% = 0{,}01 \qquad Z_{\frac{\alpha}{2}} = 1{,}96$$

$$IC(p, 1-\alpha): \left(\hat{p} - Z_{\frac{\alpha}{2}} * \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}};\ \hat{p} + Z_{\frac{\alpha}{2}} * \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right)$$

$$IC(p, 0{,}95) = \left(0{,}41 - 2{,}57 * \sqrt{\frac{0{,}41(1-0{,}41)}{100}};\ 0{,}41 - 2{,}57 * \sqrt{\frac{0{,}41(1-0{,}41)}{100}} \right)$$

$$IC(p, 0{,}95) = (0{,}41 - 0{,}126\ ;\ 0{,}41 + 0{,}126) \Leftrightarrow IC(p, 0{,}95) = (0{,}284\ ;\ 0{,}536)$$

A 1% do nível de significância, a proporção dos utentes que não aperceberam e/ou notaram o seu estado de saúde evoluir depois da consulta na ASAG, encontra-se no intervalo de 28,4% a 53,6%.

3.2.2 Testes de Hipótese

Os Testes de Hipóteses são "(…) *processos que nos permite decidir aceitar ou rejeitar uma hipótese, ou determinar se as amostras observadas diferem significativamente dos resultados esperados*." (Spiegel, 1977, p. 300). O seu objectivo consiste em "(…) *fornecer uma metodologia que nos permita verificar se os dados amostrais trazem evidências que apoiem ou não uma hipótese (estatística) formulada*", acrescenta Bussab e Morettin (2002, p.330)

- **Utentes insatisfeitos com o tempo de atendimento** (Unilateral à Direita)

Sabe-se que os utentes frequentam centros de saúde a busca de produtos (antibióticos ou fármacos) e/ou serviços com vista a solucionar algum problema de saúde que se enfrenta ou na sua família. Sendo o direito a saúde consagrado na Constituição da República Democrática de São Tomé e Príncipe, no seu ponto 1 do artigo 50.º "*Todos têm direito à protecção da saúde e o dever de a defender*" é de vital importância garantir que os utentes se sintam satisfeito com o tempo que levam para serem atendidos, uma vez que são os diferentes estágios da doença (grave e muito grave) que fazem os mesmos lá aparecerem.

[1] Tabela A (em apêndice): Evolução do estado de saúde após uma consulta na ASAG.

Entretanto, deseja-se saber se a percentagem dos utentes insatisfeitos ultrapassa os 20%, a partir dos dados da amostra[2] em relação ao tempo que levam para serem atendidos na ASAG, admitindo um nível de confiança de 95%. Sabe-se que 18 utentes mostraram-se insatisfeitos.

H_0: $p = 0{,}20 \quad vs \quad H_A$: $p > 0{,}20$

$$n = 100 \quad \hat{p} = \frac{18}{100} = 0{,}18 \quad \alpha = 5\% = 0{,}05 \quad Z_{\frac{\alpha}{2}} = 1{,}64$$

$$Z_{Obs} = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}} = \frac{0{,}18 - 0{,}20}{\sqrt{\frac{0{,}18(1-0{,}18)}{100}}} = \frac{-0{,}02}{0{,}0384} = -0{,}52$$

Como $-1{,}64 = Z_{\frac{\alpha}{2}} > Z_{Obs} = -0{,}52$, não rejeitamos a hipótese nula (H_0). Portanto, não existe evidencias suficientes que justifica a existência de mais de 20% de utentes insatisfeitos em relação ao tempo que levam para serem atendidos na ASAG.

Posso, também, confirmar a decisão com o cálculo do $p - valor$:

$p - valor = P[Z > Z_{Obs}|H_0] = P[Z > -0{,}52|H_0] = 1 - 0{,}6985 = 0{,}30.$

Como o $p - valor > \alpha$, não se rejeita a H_0.

- **O tempo de atendimento de menos de 50% dos utentes** (Unilateral a Esquerda)

Existem certas complicações na saúde que o seu diagnóstico deve ser feito com urgência de forma a evitar outras complicações.

Ter um sistema de saúde onde o atendimento é demorado e o número de utentes a espera de atendimento for permanentemente grande constitui factores para reavaliar os pontos de atendimento e dimensioná-los de maneira a atender a procura e se necessário for, promover acções de capacitação dos técnicos principalmente quando se trata de assuntos relacionados a saúde, vida humana, questões de segurança e não só.

No entanto, importa saber se no máximo 50% de utentes demoram mais de 40min para ser atendidos[3], tendo em conta que os dados do questionário revelam que 25% dos utentes esperaram mais de 40 min à um nível de confiança de 99%.

[2] Tabela B (em apêndice): Satisfação dos utentes em relação ao tempo de atendimento.
[3] Tabela C (em apêndice): Tempo de espera para o atendimento.

$H_0: p = 0{,}50 \quad vs \quad H_A: p < 0{,}50$

$n = 100 \qquad \hat{p} = \frac{25}{100} = 0{,}25 \qquad \alpha = 1\% = 0{,}01 \qquad -Z_{\frac{\alpha}{2}} = -2{,}33$

$$Z_{Obs} = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}} = \frac{0{,}25 - 0{,}50}{\sqrt{\frac{0{,}25(1-0{,}25)}{100}}} = \frac{-0{,}25}{0{,}0433} = -5{,}77$$

Como $-2{,}33 = -Z_{\frac{\alpha}{2}} > Z_{Obs} = -5{,}77$, rejeitamos a hipótese nula (H_0). Portanto, existe fortes evidencias para rejeitar a hipótese nula, ou seja, com 99% de confiança a percentagem dos utentes que demoram mais de 40min não é de 50%.

- **Proximidade dos utentes em relação a ASAG?** (Teste Bilateral)

Suponhamos que o Ministério da Saúde ambiciona ter centros de saúde próximo as comunidades, de forma a garantir a atenção primaria de saúde, uma vez que segundo o ponto 2 do artigo 50º da Constituição da República Democrática de São Tomé e Príncipe *"Incumbe ao Estado promover a Saúde Pública, que tem por objectivo o bem-estar físico e mental das populações e a sua equilibrada inserção no meio sócio-ecológico em que vivem, de acordo com o Sistema Nacional de Saúde."*

Assim, deseja testar se 75% dos utentes vão à ASAG por estar perto das suas comunidades[4].

$H_0: p = 0{,}75 \quad vs \quad H_A: p \neq 0{,}75$

$n = 100 \qquad \hat{p} = \frac{24}{100} = 0{,}24 \qquad \alpha = 5\% = 0{,}05 \qquad Z_{\frac{\alpha}{2}} = Z_{0{,}025} = 1{,}96$

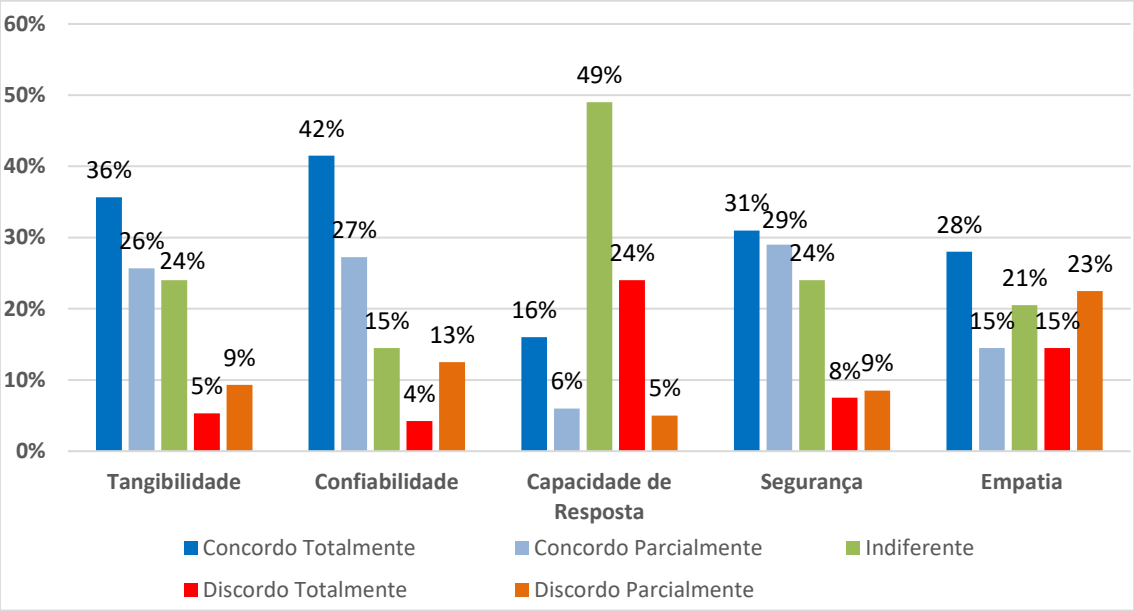
$$Z_{Obs} = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}} = \frac{0{,}24 - 0{,}75}{\sqrt{\frac{0{,}24(1-0{,}24)}{100}}} = -\frac{0{,}51}{0{,}043} = -11{,}86$$

Como $-11{,}86 = Z_{Obs} < -Z_{\frac{\alpha}{2}} = -1{,}96$, rejeitamos a hipótese nula (H_0). Portanto, existe fortes evidencias para rejeitar a hipótese nula, ou seja, com 95% de confiança, verifica-se que 75% dos utentes não frequentam ASAG apenas por estar perto das suas comunidades,

[4]Tabela D (em apêndice): Motivos que levam os utentes a frequentar ASAG.

mas também devidos outros factores como a qualidade de serviço praticado nesta área de saúde e como por recomendações de terceiros.

3.2.3 Análise das Dimensões da Qualidade



A partir dos resultados dos inquéritos mostrados no gráfico acima representado, relativo as dimensões da qualidade, ou seja, avaliação da qualidade de um serviço através da qualidade percebida pelos utentes, podemos afirmar o seguinte:

No que diz respeito a **tangibilidade**, verifica-se que a aparência das instalações físicas, dos equipamentos e dos funcionários são modernos e actualizados e que permite aos utentes a confiabilidade nas actividades desenvolvidas no referido centro, pelo facto de cerca de 62% dos utentes inqueridos ter acreditado nas variantes desta dimensão da qualidade, embora 24% mostrou-se indiferente em relação as aparências das instalações físicas e dos equipamentos e apenas 14% tem opinião contrária.

Relativamente a **fiabilidade**, percebe-se que cerca de 69% dos utentes acredita na capacidade dos profissionais desta área de saúde em efectuar os serviços prometidos de forma confiável e precisa, enquanto que 15% mostrou-se indiferente. Isto leva-nos a acreditar que os utentes buscam por cuidados de serviços neste centro devido a forma responsável, certeira e confiável como é desenvolvido as actividades neste centro.

No que respeita a vontade de ajudar os utentes e prestar o serviço prontamente – relativo a **capacidade de Resposta**, percebe-se que cerca de 49% dos utentes esta indiferente em

relação a esta dimensão da qualidade e cerca de 29% dos utentes acredita que a relação técnicos e utentes, tempo de resposta por parte dos técnicos e os serviços prestados não estão de acordo com o esperado. Apenas 22% acreditou nas variantes desta dimensão.

Relativamente ao conhecimento (competência), cortesia dos funcionários e a sua capacidade de transmitir confiança e segurança por parte dos técnicos do referido centro – referente a **segurança**, cerca de 60% dos utentes inqueridos confia e acredita que neste centro os técnicos são capacitados e com conhecimentos para realizar diagnósticos clínicos, e os seus comportamentos transmitem segurança, pese embora 24% mostrou-se indiferente em relação as competências e segurança por parte dos técnicos.

Quanto a atenção cuidadosa e individualizada, que é fornecida aos seus clientes (utentes) e facilidade de contacto e comunicação – referente a **empatia**, pela análise gráfica, verifica-se ligeiras diferenças em relação aos utentes que sentem que estão sendo bem tratados, recebendo atenção personalizada e que não existe interferência ou intruso nas comunicações entre os técnicos e utentes representando 43% dos utentes e os que têm opinião contrária representado por 38% dos utentes.